

# ABCDs 영양 평가 - A: 신체계측 파트1 (번역)

출처: AFMCP Chap4 ABCDs Nutritional Evaluation Anthropometrics Part1

## ABCD 영양 평가 개요

- A — Anthropometrics (신체계측): BMI, 허리둘레, 체성분
- B — Biomarkers (생화학): 혈액검사, 소변검사
- C — Clinical Exam (임상 신체검사): 모발·피부·손발톱·구강
- D — Diet & Lifestyle (식이·생활방식): 24시간 회상, 식품빈도지표, 식품일지
- 각 ABCD에서 얻은 정보가 서로를 안내 — 통합적으로 해석

## A-1: BMI (체질량지수)

- BMI = 체중(kg) / 키(m)<sup>2</sup>
- 정상: 18.5-24.9 / 과체중: 25-29.9 / 비만: 30 이상
- 한계: 근육량 많은 운동선수에서 과대평가; 체지방 분포 반영 안 함
- 아시아인 기준: 정상 18.5-22.9, 과체중 23-27.4, 비만 27.5 이상 (서구 기준보다 낮음)

## A-2: 허리둘레 및 비율

- 허리둘레: 여성 <35인치(88cm), 남성 <40인치(102cm) — 대사 위험 기준
- 아시아 여성: <31인치(80cm); 아시아 남성: <35인치(90cm) — 더 엄격한 기준
- 허리-엉덩이 비율(WHR): 여성 <0.85, 남성 <0.90 — 내장지방 분포 반영
- 허리-신장 비율(WHtR): <0.5 — 연령·성별 무관, 내장지방 위험 단순 평가
- 신체 원형지수(BRI): 내장지방량 추정; BRI >6.9 = 내장지방 위험

## A-3: 체성분 측정

- BIA (생체전기저항): 지방량·제지방량·체수분 측정; 저렴·간편; 수분 상태에 민감
- DEXA (이중에너지 X선 흡수계측): 체지방·근육·뼈 정밀 측정; 골표준검사
- 체지방률: 여성 정상 21-33%, 남성 8-19%; 과도한 체지방 = 대사 위험
- 내장지방(VAT): 복부 장기 주변 지방; 염증성 사이토카인 분비 → 대사증후군 핵심
- 피하지방(SAT): 피부 아래 지방; 에너지 저장·쿠션 역할; VAT보다 대사 위험 낮음
- 근육량(Lean Mass): 노인·GLP-1 사용자에서 감소 주의 (근감소증)
- 위상각(Phase Angle): BIA 측정값; 세포막 건강 지표; 낮을수록 영양·건강 불량